

Manual Oposiciones

TCAE SERMAS



Te preparamos **HOY**
para lo que el 
te pedirá **MAÑANA.**



GUÍA DE ESTUDIO PARA LA OPOSICIÓN DE TCAE SERMAS

La preparación para la oposición de TCAE SERMAS requiere una planificación cuidadosa y una metodología de estudio efectiva. A continuación, te presento una guía detallada basada en los consejos proporcionados para ayudarte a dominar el temario de manera eficiente.

1. Planificación del Estudio

- **Estructura del Temario:** Divide el temario en bloques y asigna un tiempo específico para cada uno, de acuerdo con la dificultad o extensión de los temas. Asegúrate de que la distribución del tiempo sea equilibrada para cubrir todo el contenido antes del examen.
- **Calendario de Estudio:** Crea un calendario semanal o mensual para organizar el estudio. Asegúrate de incluir días de repaso y descansos. Es esencial comenzar cuanto antes, así tendrás margen para imprevistos.
- **Objetivos Diarios y Semanales:** Establece metas claras para cada día y semana, como terminar un número determinado de temas o apartados. Cumplir estos objetivos te ayudará a mantener un ritmo constante.

2. Uso de Herramientas de Estudio

- **Esquemas y Resúmenes:** Realiza esquemas o resúmenes de cada tema para visualizar mejor la información. Los mapas conceptuales también pueden ayudarte a conectar ideas clave y mejorar la comprensión.
- **Subrayado:** Usa el subrayado como técnica para destacar las partes más importantes. Esto te ayudará a identificar rápidamente las ideas clave durante el repaso.
- **Memorización Activa:** Repite en voz alta o escribe de memoria los conceptos que te resulten más complicados. Esta técnica activa tu memoria y favorece el aprendizaje a largo plazo.

3. Resolución de Dudas

- **Consulta de Dudas:** Es importante no dejar dudas sin resolver. Si estás asistiendo a una academia, consulta con tus profesores o compañeros cualquier aspecto que no comprendas. Si estudias de manera autónoma, busca fuentes confiables para aclarar tus dudas.
- **Foros y Grupos de Estudio:** Participar en foros o grupos de estudio te permitirá intercambiar opiniones y resolver dudas de manera colaborativa.

4. Repasos Constantes

- **Revisión Periódica:** Es fundamental repasar todo lo estudiado con regularidad. Organiza sesiones de repaso semanales para reforzar lo aprendido. Cuanto más fresco tengas el material, más seguro te sentirás en el examen.
- **Simulacros de Examen:** Realiza simulacros de examen o tests de autoevaluación para medir tu progreso. Esto te ayudará a identificar los puntos débiles y mejorarlos antes de la prueba.

5. Descanso y Cuidado Personal

- **Pausas Frecuentes:** No estudies de manera ininterrumpida. Después de cada 45-50 minutos de estudio, toma un descanso de 5-10 minutos. Este método, conocido como Pomodoro, te ayudará a mantener la concentración y evitar el agotamiento.
- **Alimentación y Sueño:** Mantén una dieta equilibrada y duerme las horas necesarias para mantener tu mente alerta. La falta de sueño y una mala alimentación pueden afectar negativamente tu capacidad de concentración.
- **Actividad Física:** Incorpora ejercicio físico ligero en tu rutina diaria para liberar tensiones y mantener tu energía.

6. Consejos Finales

- **Comienza lo Antes Posible:** El tiempo es tu mejor aliado. Cuanto antes comiences con tu preparación, más seguro te sentirás y mejor podrás dominar el temario.
- **Constancia y Concentración:** Mantente constante en tus estudios, evitando distracciones y manteniendo un ambiente adecuado de estudio.

ÍNDICE

TEMA 1

1. El derecho a la protección de la salud.....	2
EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978	2
LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD	3
2. Autonomía del paciente	5
LEY 41/2002.....	5
CAPÍTULO I	5
CAPÍTULO II	8
CAPÍTULO III	9
CAPÍTULO IV	9
CAPÍTULO V	13
CAPÍTULO VI	17
ESQUEMA RESUMIDO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES	19

TEMA 1

1. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 Y EN LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

El derecho a la protección de la salud es uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar en España. Su regulación aparece recogida tanto en la **Constitución Española de 1978** como en la **Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad**, que desarrolla el marco legal del sistema sanitario español.

La Constitución Española consagra el derecho a la protección de la salud en el **Artículo 43**, dentro del **Título I**, dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Y concretamente en el **Capítulo Tercero "Principios rectores de la política social y económica"**

Artículo 43 ! !

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos **organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas** y de las **prestaciones y servicios** necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos **fomentarán** la **educación sanitaria**, la **educación física** y el **deporte**. Asimismo **facilitarán** la adecuada utilización del ocio.

Por otro lado, también hace referencia a ciertas actividades en materia de salud que realizarán las Comunidades Autónomas, así como el Estado:

Artículo 148

1. Las **Comunidades Autónomas** podrán asumir competencias en las siguientes materias:
 - 19.ª Promoción del **deporte** y de la adecuada utilización del **ocio**.
 - 20.ª **Asistencia social**.
 - 21.ª **Sanidad e higiene**.

Artículo 149

1. El **Estado tiene competencia exclusiva** sobre las siguientes materias:
 - 16.ª **Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.** ! !

RESUMEN

El derecho a la protección de la salud viene recogido en el Artículo 43 de la Constitución. En este artículo, se establece como se hará esta protección por parte de los **poderes públicos**. Además, a estos mismos poderes públicos les atribuye unas funciones de fomentar la educación en estas materias y facilitar el ocio.

Por otro lado, la Constitución divide ciertas medidas en materia de sanidad. Unas las realizarán las **Comunidades Autónomas** (artículo 148) y en otras tiene **competencia exclusiva el Estado** (artículo 149).

Competencias Comunidad Autónoma	Competencia Exclusiva Estado
Deporte	Sanidad exterior
Ocio	Bases y coordinación general sanidad
Asistencia Social	Legislar productos farmacéuticos
Sanidad e higiene	

LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD

La Ley General de Sanidad desarrolla el contenido del Artículo 43 de la Constitución y establece las bases del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto el derecho a la protección de la salud se sustenta en los siguientes puntos de la Ley. En su condición de norma básica ajustándose al art.149 de la Constitución y con arreglo a las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas según el artículo 148.

TÍTULO PRELIMINAR Del derecho a la protección de la salud

1. La presente Ley tiene por **objeto** la regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución.
2. Son **titulares del derecho** a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. **!!**
3. Los **extranjeros no residentes en España**, así como los **españoles fuera del territorio nacional**, tendrán garantizado tal derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan. **!!**
4. Para el ejercicio de los derechos que esta Ley establece están **legitimadas**, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, las **personas a que se refiere el apartado 2**.

!! Esta Ley tendrá la condición de norma básica en el sentido previsto en el artículo 149.1.16 de la Constitución y se aplicará a todo el territorio del Estado, excepto los artículos 31, apartado 1, letras b) y c), y 57 a 69, que constituirán derecho supletorio en aquellas Comunidades Autónomas que hayan dictado normas aplicables a la materia que en dichos preceptos se regula.

Las Comunidades Autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementarias de la presente Ley en el ejercicio de las competencias que les atribuyen los correspondientes Estatutos de Autonomía.

RESUMEN

La Ley General de Sanidad (**LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL**) desarrolla el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución.

El Título preliminar establece los cuatro puntos básicos en los que se va a desarrollar el derecho de protección de la salud, como son:

- **Objetivo de la ley**
- **Quienes tienen el derecho** a que se proteja su salud y se les de asistencia sanitaria
- Las peculiaridades de cómo se va a **garantizar este derecho a los extranjeros que estén en España, pero no sean residentes en ella y de los españoles que se encuentren fuera.**
- Quienes están **legitimados para acciones administrativas y judiciales** en las materias que regula la ley

En este Título preliminar también nos dice que **esta Ley tiene la condición de norma básica** para todo el territorio nacional. Las **Comunidades Autónomas pueden desarrollar y completar esta ley** según cada Estatuto de Autonomía mediante normas propias de cada una.

2. AUTONOMÍA DEL PACIENTE

LEY 41/2002, DE 14 DE NOVIEMBRE, BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA.

INTRODUCCIÓN

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es la **norma básica** que regula los derechos y deberes de los pacientes en relación con la asistencia sanitaria. Especialmente trata temas como el **consentimiento informado**, la **historia clínica** y el derecho a recibir información **clara y veraz**.

Los profesionales sanitarios que tienen contacto directo y continuo con el paciente deben conocer los derechos de los usuarios, cómo tratar su información, y cómo colaborar en la garantía del respeto a la autonomía del paciente.

OBJETIVO

- Entender los **derechos del paciente** respecto a la información y su autonomía.
- Saber qué es el **consentimiento informado** y cómo debe gestionarse.
- Conocer el uso, acceso y custodia de la **historia clínica**.
- Reconocer el papel del profesional sanitario en la aplicación de esta ley.

PUNTOS CLAVE:

1. **Consentimiento informado:** Libre, voluntario, con información suficiente y adecuada. Puede ser retirado.
2. **Derecho a la información:** Clara, comprensible, ajustada al paciente.
3. **Historia clínica:** Documento básico, confidencial, derecho de acceso.
4. **Confidencialidad:** Información solo accesible para quienes intervienen en el proceso asistencial.
5. **Importancia del TCAE:** Aunque no decide ni informa al paciente, debe **respetar, proteger y garantizar estos derechos** en su trabajo diario.

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente Ley tiene por **objeto** la **regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados**, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.

RECUERDA

La Ley regula los derechos y deberes del paciente en materia de:

- Información sanitaria
- Consentimiento informado
- Documentación clínica
- Confidencialidad

Aplica a todos los centros y profesionales sanitarios, públicos y privados.

Artículo 2. Principios básicos.

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica.
2. **Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere**, con carácter general, el previo **consentimiento** de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. **!!**
3. El paciente o usuario tiene **derecho a decidir libremente**, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
4. Todo paciente o usuario tiene **derecho a negarse al tratamiento**, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. **!!**
5. Los pacientes o usuarios tienen el **deber de facilitar los datos** sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, **especialmente** cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria. **!!**
6. **Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado** no sólo a la **correcta prestación** de sus técnicas, sino al **cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas** libre y voluntariamente por el paciente. **!!**
7. La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la **reserva debida**.

PUNTOS CLAVE

Principios básicos:

- Autonomía del paciente
- Derecho a decidir libremente tras recibir información adecuada
- Intimidad, dignidad y respeto
- Consentimiento informado como requisito previo

Artículo 3. Las definiciones legales. !!

A efectos de esta Ley se entiende por:

Centro sanitario: el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios.

Certificado médico: la declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento.

Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.

Documentación clínica: el soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial.

Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

Información clínica: todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.

Intervención en el ámbito de la sanidad: toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación.

Libre elección: la facultad del paciente o usuario de optar, libre y voluntariamente, entre dos o más alternativas asistenciales, entre varios facultativos o entre centros asistenciales, en los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes, en cada caso.

Médico responsable: el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales.

Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.

Servicio sanitario: la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias.

Usuario: la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.

CAPÍTULO II

El derecho de información sanitaria

Artículo 4. Derecho a la información asistencial.

1. Los pacientes tienen **derecho a conocer**, con motivo de cualquier actuación **en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma**, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene **derecho a que se respete su voluntad de no ser informada**. La información, que **como regla general se proporcionará verbalmente** dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. **!!**
2. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. **Los profesionales que le atiendan** durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también **serán responsables de informarle**.

Artículo 5. Titular del derecho a la información asistencial.

1. El titular del derecho a la información es el paciente. También **serán informadas las personas vinculadas** a él, por razones familiares o de hecho, **en la medida que el paciente lo permita** de manera expresa o tácita.
2. El paciente será **informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado** a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal.
3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, **carezca de capacidad para entender la información** a causa de su estado físico o psíquico, **la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas** a él por razones familiares o de hecho.
4. **El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse** por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. **Se entenderá por necesidad terapéutica** la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al paciente, **cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación pueda perjudicar su salud de manera grave**. **!!**

Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho.

Artículo 6. Derecho a la información epidemiológica.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer los problemas sanitarios de la colectividad cuando impliquen un riesgo para la salud pública o para su salud individual, y el derecho a que esta información se difunda en términos verdaderos, comprensibles y adecuados para la protección de la salud, de acuerdo con lo establecido por la Ley.

RECUERDA

El paciente tiene derecho a:

- Recibir información clara, veraz, completa y comprensible.
- Ser informado sobre diagnóstico, opciones terapéuticas, riesgos, y alternativas.
- Rechazar ser informado si así lo desea.
- Recibir la información por parte del médico responsable.

CAPÍTULO III

Derecho a la intimidad

Artículo 7. El derecho a la intimidad.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que **nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización** amparada por la Ley.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes.

CAPÍTULO IV

El respeto de la autonomía del paciente

Artículo 8. Consentimiento informado.

1. **Toda actuación** en el ámbito de la salud de un paciente **necesita el consentimiento** libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso. **!!**
2. El consentimiento **será verbal por regla general**. **!!**
Sin embargo, **se prestará por escrito** en los casos siguientes: **intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión** negativa sobre la salud del paciente. **!!**
3. El consentimiento escrito del paciente será necesario para cada una de las actuaciones especificadas en el punto anterior de este artículo, dejando a salvo la posibilidad de incorporar anejos y otros datos de carácter general, y tendrá información suficiente sobre el procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.
4. Todo paciente o usuario tiene **derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación**, que en ningún caso podrá comportar riesgo adicional para su salud.
5. El paciente puede **revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento**. **!!**

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación.

1. **La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso.** Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. **!!**
2. Los facultativos **podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: !!**
 - a) Cuando existe **riesgo para la salud pública** a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, **se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas** siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas.
 - b) Cuando existe **riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización**, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
3. Se otorgará el **consentimiento por representación** en los siguientes supuestos: **!!**
 - a) Cuando el paciente **no sea capaz de tomar decisiones**, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, **el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas** a él por razones familiares o de hecho.
 - b) Cuando el paciente tenga la **capacidad modificada judicialmente** y así conste en la sentencia.
 - c) Cuando el paciente **menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención**. En este caso, el consentimiento **lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión**, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
4. Cuando se trate de **menores emancipados o mayores de 16 años** que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, **no cabe prestar el consentimiento por representación.**
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una **actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor**, según el criterio del facultativo, **el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.**
5. La práctica de **ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida** **se rigen por** lo establecido con carácter general sobre **la mayoría de edad** y por las disposiciones especiales de aplicación.
6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, **la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente.** Aquellas decisiones que sean **contrarias a dichos intereses deberán ponerse en**

conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.

7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.

Artículo 10. Condiciones de la información y consentimiento por escrito.

1. El facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, la información básica siguiente:
 - a) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad.
 - b) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente.
 - c) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
 - d) Las contraindicaciones.
2. El médico responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente.

Artículo 11. Instrucciones previas.

1. Por el **documento** de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, **manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos** personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. **!!**
2. Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas de cada persona, que deberán constar siempre por escrito.
3. **No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico**, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones. **!!**

- Las instrucciones previas **podrán revocarse libremente en cualquier momento dejando constancia por escrito. ! !**
- Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que se registrará por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 12. Información en el Sistema Nacional de Salud.

- Además de los derechos reconocidos en los artículos anteriores, los pacientes y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán **derecho a recibir información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los requisitos de acceso** a ellos.
- Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o carta de los servicios en la que se especifiquen los derechos y obligaciones de los usuarios, las prestaciones disponibles, las características asistenciales del centro o del servicio, y sus dotaciones de personal, instalaciones y medios técnicos.
Se facilitará a todos los usuarios información sobre las guías de participación y sobre sugerencias y reclamaciones.
- Cada servicio de salud regulará los procedimientos y los sistemas para garantizar el efectivo cumplimiento de las previsiones de este artículo.

Artículo 13. Derecho a la información para la elección de médico y de centro.

Los usuarios y pacientes del Sistema Nacional de Salud, tanto en la **atención primaria como en la especializada**, tendrán derecho a la información previa correspondiente para **elegir médico, e igualmente centro**, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de salud competentes. **! !**

RECUERDA

Consentimiento informado

- Aceptación libre y voluntaria del paciente tras recibir información suficiente.

Tipos:

- Verbal → intervenciones rutinarias.
- Escrito → intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasivos o con riesgos significativos.

Puede ser revocado en cualquier momento.

Excepciones al consentimiento informado

No se requiere consentimiento:

- En situaciones de riesgo vital inmediato.
- Cuando el paciente no está en condiciones de decidir.
- Cuando existe peligro grave para la salud pública.
- En situaciones determinadas por imperativo legal.

Artículo 14. Definición y archivo de la historia clínica.

1. La historia clínica comprende el **conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente**, con la identificación de los médicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro. **!!**
2. **Cada centro archivará las historias clínicas de sus pacientes, cualquiera que sea el soporte** papel, audiovisual, informático o de otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación y la recuperación de la información.
3. Las Administraciones sanitarias establecerán los mecanismos que garanticen la autenticidad del contenido de la historia clínica y de los cambios operados en ella, así como la posibilidad de su reproducción futura.
4. Las Comunidades Autónomas aprobarán las disposiciones necesarias para que los centros sanitarios puedan adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para archivar y proteger las historias clínicas y evitar su destrucción o su pérdida accidental.

Artículo 15. Contenido de la historia clínica de cada paciente.

1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. **Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales**, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. **!!**
2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud.
El **contenido mínimo de la historia clínica** será el siguiente: **!!**
 - a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.
 - b) La autorización de ingreso.
 - c) El informe de urgencia.
 - d) La anamnesis y la exploración física.
 - e) La evolución.
 - f) Las órdenes médicas.
 - g) La hoja de interconsulta.
 - h) Los informes de exploraciones complementarias.
 - i) El consentimiento informado.
 - j) El informe de anestesia.
 - k) El informe de quirófano o de registro del parto.
 - l) El informe de anatomía patológica.

- m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
- n) La aplicación terapéutica de enfermería.
- ñ) El gráfico de constantes.
- o) El informe clínico de alta.

Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.

3. Cuando se trate del **nacimiento**, la historia clínica incorporará, **además** de la información a la que hace referencia este apartado, los resultados de las **pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su caso, necesarias** para determinar el vínculo de filiación con la madre, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
4. La historia clínica se llevará con criterios de **unidad y de integración**, en cada institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial. **!!**
5. Cuando la atención sanitaria prestada lo sea a consecuencia de violencia ejercida contra personas menores de edad, la historia clínica especificará esta circunstancia, además de la información a la que hace referencia este apartado.

Artículo 16. Usos de la historia clínica.

1. La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los **profesionales asistenciales** del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente **tienen acceso** a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
2. Cada centro establecerá los métodos que posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que le asisten.
3. El acceso a la historia clínica con **finés judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia**, se rige por lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso. El acceso a la historia clínica con estos fines obliga a preservar los **datos de identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínicoasistencial**, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos. **!!**

Se exceptúan los supuestos de investigación previstos en el apartado 2 de la Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Asimismo **se exceptúan los supuestos de investigación de la autoridad judicial en los que se considere imprescindible la unificación de los datos identificativos** con los clínicoasistenciales, en los cuales se estará a lo que dispongan los jueces y tribunales en el proceso correspondiente. El acceso a los datos y documentos de la historia clínica queda limitado estrictamente a los fines específicos de cada caso.

Cuando ello sea necesario para la prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población, las Administraciones sanitarias a las que se refiere la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, podrán acceder a los datos identificativos de los pacientes por razones epidemiológicas o de protección de la salud pública. El acceso habrá de realizarse, en todo caso, por un profesional

sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta, asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte de la Administración que solicitase el acceso a los datos.

4. El **personal de administración y gestión** de los centros sanitarios **sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones**.
!!
5. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza **funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación, tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones** de comprobación de la calidad de la asistencia, el respeto de los derechos del paciente o cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.
6. El **personal que accede a los datos** de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al **deber de secreto**.
7. Las Comunidades Autónomas regularán el procedimiento para que quede constancia del acceso a la historia clínica y de su uso.

Artículo 17. La conservación de la documentación clínica.

1. Los **centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica** en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, **como mínimo, cinco años** contados **desde la fecha del alta** de cada proceso asistencial. **!!**

No obstante, **los datos de la historia clínica relacionados con el nacimiento** del paciente, incluidos los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, **no se destruirán**, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los archivos definitivos de la Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos.

2. La **documentación clínica también se conservará a efectos judiciales** de conformidad con la legislación vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la identificación de las personas afectadas.

Sin perjuicio del derecho al que se refiere el artículo siguiente, los datos de la historia clínica relacionados con las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre del recién nacido, sólo podrán ser comunicados a petición judicial, dentro del correspondiente proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna.

3. **Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el mantenimiento de una documentación clínica ordenada** y secuencial del proceso asistencial de los pacientes.
4. La gestión de la historia clínica por los centros con pacientes hospitalizados, o por los que atiendan a un número suficiente de pacientes bajo cualquier otra modalidad asistencial, según el criterio de los servicios de salud, se realizará a través de la unidad de admisión y documentación clínica, encargada de integrar en un solo archivo las historias clínicas. La custodia de dichas historias clínicas estará bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario.

5. Los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad de manera individual son responsables de la gestión y de la custodia de la documentación asistencial que generen.
6. Son de aplicación a la documentación clínica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.

1. El paciente tiene el **derecho de acceso**, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la **documentación de la historia clínica** y a obtener **copia de los datos que figuran** en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos.
2. El **derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación** debidamente acreditada. **!!**
3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.
4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo **facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido** expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. **!!**

Artículo 19. Derechos relacionados con la custodia de la historia clínica.

El paciente tiene derecho a que los centros sanitarios establezcan un **mecanismo de custodia activa y diligente** de las historias clínicas. Dicha custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al principio de confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley.

RECUERDA

Historia clínica

- Conjunto de documentos que recogen todos los datos, valoraciones y actuaciones sobre el proceso asistencial de un paciente.

Derechos del paciente:

- Acceder a su historia.
- Obtener copia.
- Corrección de datos si hay errores.



Conservación: mínimo 5 años desde el alta.

Confidencialidad de los datos

- Toda la información relativa a la salud del paciente es confidencial.

Acceso solo:

- Por parte del personal que interviene directamente en la atención.
- En casos legales, judiciales, o motivos epidemiológicos debidamente justificados.

CAPÍTULO VI

Informe de alta y otra documentación clínica

Artículo 20. Informe de alta.

Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las Administraciones sanitarias autonómicas.

Artículo 21. El alta del paciente.

1. **En caso de no aceptar el tratamiento prescrito**, se propondrá al paciente o usuario la **firma del alta voluntaria**. Si no la firmara, la dirección del centro sanitario, a propuesta del médico responsable, podrá disponer el **alta forzosa** en las condiciones reguladas por la Ley.

El hecho de **no aceptar el tratamiento prescrito no dará lugar al alta forzosa cuando existan tratamientos alternativos**, aunque tengan carácter paliativo, siempre que los preste el centro sanitario y el paciente acepte recibirlos. Estas circunstancias quedarán debidamente documentadas.

2. **En el caso de que el paciente no acepte el alta**, la dirección del centro, previa comprobación del informe clínico correspondiente, oirá al paciente y, si persiste en su negativa, **lo pondrá en conocimiento del juez** para que confirme o revoque la decisión. **!!**

Artículo 22. Emisión de certificados médicos.

Todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Éstos serán **gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria**. **!!**

Artículo 23. Obligaciones profesionales de información técnica, estadística y administrativa.

Los profesionales sanitarios, además de las obligaciones señaladas en materia de información clínica, tienen el **deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos** clínicos en los que intervienen, y los que requieran los centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la investigación médica y la información epidemiológica.

RECUERDA

Documentación clínica

Incluye:

- Informes de alta
- Consentimientos informados
- Resultados de pruebas
- Informes de urgencias, interconsultas, etc.

El paciente puede:

- Solicitar y recibir copia de toda la documentación que le concierna.

Disposición adicional. Carácter de legislación básica.

Esta Ley tiene la **condición de básica**, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución. **!!**

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor en el plazo de **seis meses** a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». **!!**

ESQUEMA RESUMIDO DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

Principios generales

- Define la **autonomía del paciente**: derecho a decidir libremente sobre su salud.
- Toda actuación requiere el **consentimiento del paciente**, previamente informado.
- Reconoce el derecho a la **intimidad, dignidad y confidencialidad**.

Derecho a la información sanitaria

- El paciente tiene derecho a ser informado **de forma comprensible y veraz**.
- Se debe informar sobre: diagnóstico, tratamientos, riesgos, alternativas, y consecuencias de no actuar.
- El derecho a no ser informado también se respeta (excepto si hay riesgo a terceros).

Derecho a la intimidad y al consentimiento informado

- La información médica es **confidencial**.
- El **consentimiento informado** es necesario para cualquier intervención (excepto urgencias o riesgos vitales).
- Puede ser verbal, pero en casos como intervenciones quirúrgicas o pruebas invasivas, **debe constar por escrito**.
- El paciente **puede revocar su consentimiento en cualquier momento**.

Historia clínica

- Es el conjunto de documentos que contienen los datos sobre el proceso asistencial de un paciente.
- Todo profesional que intervenga en la asistencia debe dejar constancia en ella.
- El paciente tiene derecho a **acceder y obtener copia de su historia clínica**, salvo excepciones (datos que puedan perjudicar a terceros, etc.).
- Se deben conservar al menos **5 años desde la fecha de alta**.

Confidencialidad de la información

- Los datos personales de salud son **información especialmente protegida**.
- Solo se puede acceder a ellos por profesionales implicados en la asistencia.
- Se puede acceder por razones epidemiológicas, judiciales, o por interés público, con garantías.

Documentación clínica

Incluye:

- **Informe de alta**
- **Consentimientos informados**
- **Pruebas diagnósticas**
- El paciente tiene derecho a obtener copia de estos documentos.

